

Anamnèse Sexuelle

0. Cadre général

Définition : la sexualité est vécue et exprimée à travers les pensées, fantasmes, désires, croyances (ex. : ancien discours médical de 'pseudo-science' qui affirmait que la masturbation rendait aveugle), attitudes (ex. : homophobie), valeurs (ex. : consentement), comportements (ex. : évitement face aux déviances), pratiques (ex. : SM), rôles et relation (OMS).

La sexualité fait notamment intervenir les termes de **genre**, d'**orientation** et de **pratiques** (pas toujours tous en adéquation !), mais également la pensée, le sentiment et le vécu.

La sexualité humaine se trouve au **carrefour** du **biologique** (influencé par des médicaments, des maladies, ou encore les hormones pendant et après l'adolescence), **psychosomatique** (interface entre le corps et le soma, qui est capital dans la sexualité, car on retrouve un lien indissociable entre ces deux aspects de la personnalité), **psychique** (profondément relationnel et associé à des sentiments forts comme la culpabilité après une infidélité par exemple), **social** (les strates sociales dans lesquelles on habite détermine en partie notre sexualité, ces strates dépendant des interdits de notre culture, des préventions scolaires, des stéréotypes, etc.), **historique**, **culturel** (fort rapport avec la religion et la 'morale') et **sociétal** (ex. : les grecs considéraient l'homosexualité comme quelque chose de tout à fait normal, alors qu'une question très épineuse était de savoir qui doit être actif et qui doit être actif pendant l'acte).

La sexualité est placée dans plusieurs cadres de référence : **légal** (pédophilie doit être déclarée, ainsi que tout autre pratique pouvant faire du mal à autrui), éthique (est-ce que c'est juste ou pas, où intervient par exemple la notion de consentement), moral (est-ce que c'est acceptable ou pas, change avec le temps, comme par exemple l'avortement avant et de nos jours) et psychologique/ sociologique (comment je peux comprendre ce phénomène, par l'utilisation de la psychanalyse par exemple (ex. : exhibitionnistes : est-ce que ce serait des hommes qui auraient simplement besoin de constamment réaffirmer leur puissance et leur virilité en faisant peur ?)).

1. (Physiologique de la sexualité) (pas vu cette année)

Avant, il y a encore une **phase de désir** : chaque phase peut être associée à des troubles particuliers.

- a. Phase d'excitation
- b. Phase de plateau
- c. Phase de l'orgasme
- d. Phase de résolution

L'anatomie permet de structurer l'anamnèse

Parfois dans l'anamnèse sexuelle, il faut **juste informer le patient** !

La taille du pénis et le point G sont des objets de fantasmes, de discours, de marchandises. Ils constituent donc **plus qu'une réalité biologique**.

2. Anamnèse sexuelle au cabinet

Les consultations pour des problèmes sexuels **représentent près de 15% des consultations totales**.

Les sujets couramment abordés sont les dysfonctions sexuelles, les orientations sexuelles, les abus et violences sexuelles, les MST, les grossesses (désirées ou non) et les infertilités.

Plus de 95% des patients jugent normal que le médecin **investigue la sphère sexuelle** !

Il existe plusieurs émotions fortement liées à la sexualité, **angoisse, dégoût, culpabilité, honte et gêne** (fait que l'on n'en parle pas) qui nous guident. La **honte** est très liée au fait que **l'on se sent différent** des autres (conformisme actuel). La honte **signale la différence** et peut amener à faire des chose idiotes pour se conformer aux autres = **sentiment social**.

Cette **honte** est quelque chose que le médecin doit à tout prix **éviter**, sinon il risque de ne pas évoquer certains sujets, qui pourtant sont indispensables à aborder. Pour éviter cette honte et ce gêne de parler de la sexualité, le médecin doit d'abord faire une **réflexion sur la sexualité**, sur les stéréotypes, croyances, attitudes, etc. qu'il pourrait avoir face à la sexualité. Ainsi, si le médecin est au clair sur ces points, il diminuera la gêne lors de l'entretien, ce qui permettra au patient de s'ouvrir encore davantage.

3. Conditions générales de l'anamnèse sexuelle

Les patients dévoilent ce que le médecin peut entendre. Il faut reconnaître ses **propres attitudes, angoisses et gênes** (qu'est-ce que je pense des perversions, des prostituées ?). Il est important **de connaître ses limites** et orienter le patient ailleurs.

Un point important est le **choix du langage** : il est très difficile, mais très important, de savoir trouver les mots et de poser les bonnes questions pour **éviter de paraître trop insistant, trop gênant**, au risque de voir le patient se refermer sur lui-même et de se rétracter.

- a. Comment entrer en matière sur le champs de la sexualité : chercher les portes d'entrée (ganglions, fatigue, qui se déploie sur le champs de la sexualité)
- b. **Expliciter le secret médical** et ne pas hésiter à rappeler qu'on se trouve dans un cabinet médical, ce qui signifie que tout ce qui est dit est strictement confidentiel
- c. **Nommer le climat émotionnel** : je comprends que c'est difficile pour vous de parler de ce genre de sujet, surtout s'il y a une différence d'âge et de sexe entre nous. Si certains sujets sont trop gênants ou si vous trouvez mes questions trop insistantes, n'hésitez pas à me le faire savoir ou à m'interrompre à tout moment
- d. **Langage adapté** : attention à la rationalisation
- e. **Investigation** : on ne fait pas une inquisition (patient toujours libre de répondre ou non)
- f. **Présence de symptômes** : il faut les décrire et les contextualiser (contexte relationnel qui s'inscrit dans une vie)
- g. **Rassurer sur la normalité** : de nombreux patients viennent en pensant avoir des problèmes anormaux touchant à la sexualité, notamment concernant la taille de leur pénis ou encore leur homosexualité ; dans ce deuxième cas, il est important de rassurer le patient en lui affirmant que même si cette sexualité est minoritaire, elle n'est **en aucun cas** un problème psychiatrique ou une 'maladie' dont il faudrait avoir honte

La sexualité est **surdéterminée** avec le contexte social, sociétal et psychique, C'est une infraction dans la sphère intime de la personne, il faut en être conscient. Les émotions générées peuvent provoquer de l'évitement et un silence. Ainsi, le patient peut choisir de ne **s'ouvrir qu'à certaines personnes**, ce qui implique qu'il faut aussi se renseigner auprès du personnel soignant en contact avec le patient pour savoir si le patient aurait fait quelques confessions.

Un autre point est la différence entre **penser, sentir et faire**. En effet, les patients sont libres de penser ce qu'ils veulent, mais certaines choses n'étant politiquement pas 'correctes', ils ne peuvent pas réaliser tous leurs fantasmes (ex. : pédophilie). On pourrait comparer ces différences aux régimes démocratique (= on peut dire beaucoup de chose, tout penser, mais pas tout faire), dictatorial (= on ne peut pas tout dire, tout penser, mais pas tout faire) et totalitariste (on ne peut rien dire, penser et faire).

Il est aussi important de garder à l'esprit la **déontologie médicale**, qui n'interdit pas de ressentir de l'attirance envers les patients, mais qui condamne toute forme d'attouchement ou autre forme de pratiques touchant à la sexualité avec les patients dans le domaine du médical.

4. Sexualité et dysfonctions sexuelles

La sexualité correspond à toute forme **d'expression ou de manifestations consciente ou inconsciente de l'identité sexuée et de l'imaginaire érotique** (usage sexuel du non-sexuel comme le pouvoir et l'argent, et usage non-sexuel du sexuel comme le viol). Les trois principaux problèmes liés à la sexualité sont les troubles **du désir, de l'excitation et du plaisir**.

4.1. Troubles du désir

Certaines personnes **ressentent moins de désir**, plus de désir, voire parfois même une aversion (provient forcément d'une expérience traumatisante, comme un viol) pour la sexualité. Les troubles du désir peuvent avoir de nombreuses origines : **troubles psychiatriques** (dépression (enlève tout plaisir !), troubles bipolaires), maladies somatiques (ex. : artériosclérose, qui peut toucher le pénis dans les phases tardives et rendre les érections très difficiles), **effets secondaires de médicaments** (antidépresseur, chimiothérapies (ex. : comme ce traitement détruit les muqueuses, les femmes ressentent beaucoup de douleurs pendant les rapports !)), contexte relationnel, angoisse, pression, **traumatisme et éducation**.

Les troubles du désir peuvent aussi être dans l'autre extrême, c'est à dire l'hypersexualité ou d'addiction.

Chez la **femme**, la perte du désir constitue le trouble sexuel le plus **fréquent**, particulièrement après la naissance de l'enfant. Chez l'homme, le trouble du désir apparaît souvent dans les contextes de **burn-out**.

4.2. Trouble de l'excitation

Le trouble de l'excitation chez les femmes se traduit principalement par une **diminution de la lubrification**. Ce phénomène est physiologique avec le vieillissement de la femme à cause de la diminution de la quantité d'oestrogènes. En revanche il est pathologique chez la femme jeune.

Chez les hommes, c'est les **problèmes d'érection** qui prédominent. La prévalence augmente également avec l'âge (50% pour les patients de 70-80 ans). Le trouble de l'érection est souvent lié à une **maladie somatique**, par exemple les manifestations coronariennes. Il s'ancre aussi dans un contexte relationnel important.

De manière générale, cette excitation peut être **hypertrophiée** (ex. : maniaques, qui sont trop impliqué dans tout), ou au contraire **diminuée**, voir absente (ex. : on peut avoir un désir, mais pas d'excitation, comme chez les femmes avec une diminution de la lubrification).

4.3. Troubles du plaisir

Le trouble du plaisir est une **insatisfaction**, particulièrement en l'**absence d'orgasme** (ex. : on pourrait avoir un désir, une excitation, mais une absence totale d'orgasme). Chez la femme, il est souvent dû à un rapport au corps non-satisfaisant, sentiment de culpabilité, une relation non-satisfaisante ou des angoisses. Des douleurs sont elles plutôt associées à des traumatismes.

Chez l'homme, le problème le plus fréquent **c'est l'éjaculation précoce** (trouble sexuel le plus fréquent qui génère une forte sensation de honte)

4.4. Paraphilies

Explorer les éventuelles '**déviances**' **sexuelles**, comme le SM par exemple

4.4. Dysphories

Explorer les éventuels troubles de l'identité sexuelle

5. (Approfondir l'investigation)

Lors de l'anamnèse sexuelle, il est important **d'approfondir au mieux la plainte**. Il faut déterminer le contexte dans lequel émerge le trouble, sa fréquence, sa durée, intensité et ses conséquences.

Les contextes **mentaux, sociaux et culturels** doivent être pris en compte. Le regard sur soi-même, sa perception des autres, ses fantasmes, la contraception, le désir d'enfant et la communication avec le partenaire sont également des points importants à aborder.

Enfin, il est souvent utile **d'en savoir plus sur la vie**, la biographie de la personne, c'est à dire la sexualité dans sa famille, la présence de situation abusive, le nombre de partenaires, l'éducation et la religiosité reçues pendant l'enfance.

On s'intéresse aussi **à l'émergence de la sexualité** et donc le rôle clé de la puberté (traumatisme, masturbation). En somme, il est important de cerner le trouble mais aussi de savoir dans quel contexte il s'inscrit.

6. Aspects supplémentaires de la sexualité dans le cabinet médical

On peut aussi aborder les points suivants :

- Discours de prévention et comportements à risques (important chez les jeunes)
- Contraception et grossesses, désirées ou non
- MST
- Problèmes de couple
- Dysphorie de genre
- Effets secondaires des médicaments prescrits (en général et sur la sexualité)